



FORMATION PLUS

L'excellence au Cœur de la santé



PÉDIATRIE MÉDICALE

PARTIE 1 — QCD(QUESTIONS À CHOIX DOUBLE)

1. Le très grand prématuré correspond à un âge gestationnel compris entre 22 et 27 SA + 6 jours.
☐ Vrai ☐ Faux
2. L'hypotrophie est, par définition, un nouveau-né prématuré présentant un poids inférieur à la normale.
☐ Vrai ☐ Faux
3. Dans l'hypotrophie harmonieuse, le périmètre crânien est également diminué, comme le poids et la taille.
☐ Vrai ☐ Faux
4. Le nouveau-né post-terme naît après 42 semaines d'aménorrhée.
☐ Vrai ☐ Faux
5. Le nouveau-né de mère diabétique présente une macrosomie harmonieuse, avec un périmètre crânien augmenté.
☐ Vrai ☐ Faux
6. L'hypoglycémie néonatale est LE risque métabolique principal chez le nouveau-né de mère diabétique.
☐ Vrai ☐ Faux
7. Un score de Silverman supérieur ou égal à 3 impose une référence urgente en milieu spécialisé.
☐ Vrai ☐ Faux
8. Le score d'APGAR n'est calculé qu'une seule fois, à la 1ère minute de vie.
☐ Vrai ☐ Faux
9. En réanimation néonatale, on doit arrêter les manœuvres si le cœur ne bat toujours pas après 30 minutes bien conduites.
☐ Vrai ☐ Faux
10. Le score infectieux de Houenou permet d'orienter la décision d'antibiothérapie probabiliste chez le nouveau-né.
☐ Vrai ☐ Faux
11. Il faut toujours laisser un nouveau-né icterique dans une pièce sombre pour le protéger de la lumière.
☐ Vrai ☐ Faux
12. La prévention de la maladie hémorragique du nouveau-né repose sur l'administration systématique de vitamine K1.
☐ Vrai ☐ Faux
13. On peut masser un céphalématome pour accélérer sa résorption.
☐ Vrai ☐ Faux
14. Les dermatoses transitoires du nouveau-né nécessitent toujours un traitement antibiotique spécifique.
☐ Vrai ☐ Faux
15. La voie rectale est la voie de référence pour mesurer la température chez l'enfant.
☐ Vrai ☐ Faux
16. Chez le nourrisson, le paludisme grave et la méningite bactérienne dominent les causes de convulsions occasionnelles.
☐ Vrai ☐ Faux
17. Une anémie microcytaire hypochrome oriente en premier lieu vers une carence martiale.
☐ Vrai ☐ Faux
18. Chez le nouveau-né sans fièvre présentant des vomissements, il faut toujours évoquer une cause chirurgicale.
☐ Vrai ☐ Faux

19. La présence d'au moins 2 signes dans une colonne classe l'enfant dans le plan de déshydratation correspondant (A, B ou C).

☐ Vrai ☐ Faux

20. Il faut arrêter toute alimentation pendant la durée complète d'une diarrhée aiguë.

☐ Vrai ☐ Faux

21. L'artésunate injectable est le traitement de 1ère intention du paludisme grave de l'enfant.

☐ Vrai ☐ Faux

22. Le diagnostic biologique n'est pas nécessaire avant de débiter un traitement antipaludique chez l'enfant.

☐ Vrai ☐ Faux

23. L'épiglottite est une urgence pédiatrique extrême où il ne faut jamais examiner la gorge.

☐ Vrai ☐ Faux

24. L'otite moyenne aiguë est la complication la plus fréquente de la rhinopharyngite.

☐ Vrai ☐ Faux

25. La paracentèse est systématique chez le nourrisson de moins de 3 mois présentant une otite.

☐ Vrai ☐ Faux

26. Le lit d'un enfant asthmatique peut comporter une couverture en laine sans aucun problème.

☐ Vrai ☐ Faux

27. Il faut forcer un nourrisson à manger en cas d'anorexie du nourrisson, pour éviter la dénutrition.

☐ Vrai ☐ Faux

28. Le kwashiorkor se caractérise par des œdèmes associés à un appétit conservé.

☐ Vrai ☐ Faux

29. Le marasme se caractérise par une fonte musculaire et grasseuse, avec un appétit conservé.

☐ Vrai ☐ Faux

30. Il faut faire vomir systématiquement tout enfant ayant ingéré un produit caustique ou du pétrole.

☐ Vrai ☐ Faux

31. Une odeur de souris de la peau et des urines chez un nourrisson doit faire évoquer une phénylcétonurie.

☐ Vrai ☐ Faux

32. Chez le nourrisson, l'absence de raideur de nuque élimine formellement le diagnostic de méningite.

☐ Vrai ☐ Faux

33. Les 3 besoins fondamentaux prioritaires du prématuré sont : téter, respirer, maintenir sa température.

☐ Vrai ☐ Faux

34. L'ictère nucléaire est une complication bénigne et totalement réversible de l'ictère du nouveau-né.

☐ Vrai ☐ Faux

35. Il est recommandé de donner une tape vigoureuse sur les fesses du nouveau-né pour stimuler sa respiration.

☐ Vrai ☐ Faux

36. La maladie des membranes hyalines touche principalement le nouveau-né prématuré.

☐ Vrai ☐ Faux

37. Les solutés hypertoniques comme le SG30% sont recommandés pour réhydrater un enfant déshydraté.

☐ Vrai ☐ Faux

38. Le TDR (test de diagnostic rapide) peut être utilisé de façon fiable pour le suivi post-thérapeutique du paludisme.

☐ Vrai ☐ Faux

39. La déshydratation survenant pendant le traitement du malnutri sévère a une mortalité élevée (50 à 80%).

☐ Vrai ☐ Faux

40. Chez le nourrisson, la ponction lombaire doit être réalisée facilement, dès la moindre suspicion de méningite.

☐ Vrai ☐ Faux

41. Le petit prématuré (35-36 SA + 6 jours) représente la catégorie la plus fréquente parmi les prématurés.

☐ Vrai ☐ Faux

42. La recherche de la cause d'une détresse respiratoire néonatale doit toujours précéder la mise en route du traitement.

☐ Vrai ☐ Faux

43. Le Streptocoque B est un germe précoce dominant dans les infections bactériennes néonatales.

☐ Vrai ☐ Faux

44. L'otite moyenne aiguë touche principalement les enfants entre 8 mois et 2 ans.

☐ Vrai ☐ Faux

45. La galactosémie congénitale se révèle généralement par un ictère prolongé et une cataracte.

☐ Vrai ☐ Faux

PARTIE 2 — QUESTIONS À CHOIX MULTIPLES

1. Quel est l'âge gestationnel correspondant au « grand prématuré » ?
 - A. 22 à 27 SA
 - B. 28 à 32 SA
 - C. 33 à 34 SA
 - D. 35 à 36 SA
2. Le nouveau-né hypotrophe est défini par un poids de naissance inférieur à :
 - A. 1500 g
 - B. 2000 g
 - C. 2500 g
 - D. 3000 g
3. Quel signe cutané est caractéristique du nouveau-né post-terme ?
 - A. Vernix caseosa abondant
 - B. Ongles teintés de méconium
 - C. Lanugo abondant
 - D. Œdème généralisé
4. Quel est le principal risque métabolique chez le nouveau-né de mère diabétique ?
 - A. L'hyperglycémie
 - B. L'hypoglycémie
 - C. L'hypercalcémie
 - D. L'hyperkaliémie
5. Le score de Silverman évalue :
 - A. La douleur du nouveau-né
 - B. La gravité de la détresse respiratoire
 - C. Le niveau de conscience
 - D. Le degré de déshydratation
6. Un score d'APGAR inférieur à 3 correspond à :
 - A. Une bonne adaptation
 - B. Une souffrance modérée
 - C. Une mort apparente
 - D. Un état normal
7. Parmi les germes suivants, lequel N'est PAS un germe précoce dominant de l'infection bactérienne néonatale ?
 - A. Streptocoque B
 - B. E. coli K1
 - C. Listeria monocytogenes
 - D. Staphylocoque doré
8. Quel signe est caractéristique de l'ictère nucléaire constitué ?
 - A. Hypotonie généralisée
 - B. Plafonnement du regard
 - C. Fièvre isolée
 - D. Diarrhée profuse
9. Quelle est la posologie de vitamine K1 recommandée en prévention systématique à la naissance ?
 - A. 1 mg
 - B. 5 mg
 - C. 10 mg
 - D. 20 mg
10. Quelle caractéristique distingue le céphalématome de la bosse séro-sanguine ?
 - A. Il chevauche les sutures
 - B. Il ne chevauche pas les sutures
 - C. Il disparaît en 24 heures
 - D. Il est toujours bilatéral
11. Quel est le traitement médicamenteux de 1ère intention de la fièvre chez l'enfant ?
 - A. L'ibuprofène
 - B. L'aspirine
 - C. Le paracétamol
 - D. La cortisone
12. Quel médicament est utilisé en 1ère intention pour arrêter une convulsion aiguë de l'enfant ?
 - A. Le phénobarbital

- B. Le diazépam
 - C. La quinine
 - D. L'artésunate
13. Quel type d'anémie oriente vers un paludisme ou une drépanocytose ?
- A. Microcytaire hypochrome
 - B. Normocytaire normochrome
 - C. Macrocytaire normochrome
 - D. Aucune de ces réponses
14. Chez le nouveau-né sans fièvre présentant des vomissements, quelle cause doit être évoquée en priorité ?
- A. Le paludisme
 - B. Une cause chirurgicale
 - C. Une intoxication alimentaire
 - D. Une otite
15. Quel plan de traitement correspond à une déshydratation sévère ?
- A. Plan A
 - B. Plan B
 - C. Plan C
 - D. Plan D
16. Quelle molécule est recommandée en 1ère intention pour le paludisme grave de l'enfant ?
- A. La chloroquine
 - B. L'artésunate injectable
 - C. Le paracétamol
 - D. L'amoxicilline
17. Quelle pathologie constitue une urgence pédiatrique extrême où il ne faut jamais examiner la gorge ?
- A. La rhinopharyngite
 - B. L'angine
 - C. L'épiglottite
 - D. La bronchiolite
18. Quelle est la tranche d'âge la plus concernée par la rhinopharyngite ?
- A. 0 à 6 mois
 - B. 6 mois à 2 ans
 - C. 5 à 10 ans
 - D. Plus de 10 ans
19. Quel aspect du tympan signe une collection suppurée ?
- A. Tympan normal, translucide
 - B. Tympan congestif rosé
 - C. Tympan bombé, rouge violacé
 - D. Tympan perforé sec
20. Quelle est la 1ère affection broncho-pulmonaire chronique de l'enfant en Côte d'Ivoire ?
- A. La bronchiolite
 - B. La coqueluche
 - C. L'asthme
 - D. La tuberculose
21. Que faut-il faire devant une anorexie commune du nourrisson ?
- A. Forcer l'enfant à manger
 - B. Rassurer les parents et mettre l'enfant en position de demandeur
 - C. Prescrire systématiquement des vitamines
 - D. Hospitaliser systématiquement l'enfant
22. Quel lait thérapeutique est utilisé en phase initiale de la malnutrition aiguë sévère ?
- A. Le F100
 - B. Le F75
 - C. Le lait maternisé standard
 - D. Le lait de vache entier
23. Quel signe distingue principalement le kwashiorkor du marasme ?
- A. Les œdèmes
 - B. La fièvre
 - C. La toux
 - D. Les vomissements
24. Que faire devant une ingestion de pétrole chez l'enfant ?
- A. Faire vomir immédiatement
 - B. Donner du lait pour diluer
 - C. Ne pas faire vomir
 - D. Donner de l'huile de palme

25. Quel examen permet le diagnostic de la phénylcétonurie ?
- A. Le test de Guthrie
 - B. La goutte épaisse
 - C. L'échographie
 - D. Le scanner
26. Quel germe est évoqué devant un diplocoque Gram positif encapsulé au LCR ?
- A. Haemophilus influenzae
 - B. Streptococcus pneumoniae
 - C. Neisseria meningitidis
 - D. Escherichia coli
27. Les dermatoses transitoires du nouveau-né nécessitent-elles un traitement spécifique ?
- A. Oui, systématiquement des antibiotiques
 - B. Oui, systématiquement des antifongiques
 - C. Non, elles guérissent spontanément
 - D. Oui, une chirurgie est nécessaire
28. Quelle est la voie recommandée pour l'administration de la vitamine K1 chez le prématuré sain ?
- A. Voie orale uniquement
 - B. Voie intramusculaire
 - C. Voie intraveineuse directe
 - D. Voie sous-cutanée
29. Quel terme désigne l'aspect d'un hypotrophe disharmonieux ?
- A. Aspect de « petit vieux »
 - B. Aspect « d'araignée »
 - C. Aspect « de poupée »
 - D. Aspect « de grenouille »
30. Au bout de combien de temps doit-on arrêter la réanimation néonatale si le cœur ne bat toujours pas ?
- A. Après 5 minutes
 - B. Après 15 minutes
 - C. Après 30 minutes
 - D. Après 1 heure
31. Quelle est la définition du nouveau-né hypotrophe ?
- A. Né avant terme avec un petit poids
 - B. Né à terme avec un poids de naissance inférieur à 2500g
 - C. Né après terme avec macrosomie
 - D. Né avec une malformation congénitale
32. Quel geste est recommandé chez un nouveau-né ictérique sans signe de danger ?
- A. L'exposer à la lumière du jour
 - B. Le laisser dans une pièce sombre
 - C. Le mettre sous antibiotiques systématiques
 - D. Réaliser une exsanguino-transfusion d'emblée
33. Quel signe clinique définit le kwashiorkor ?
- A. La fonte musculaire isolée
 - B. Les œdèmes
 - C. La fièvre élevée
 - D. La toux chronique
34. Quel geste est systématique chez le nourrisson de moins de 3 mois présentant une otite ?
- A. La paracentèse
 - B. L'amygdalectomie
 - C. Le lavage d'oreille
 - D. Aucun geste particulier
35. Quel examen oriente le diagnostic de galactosémie congénitale ?
- A. Le test de Guthrie
 - B. La recherche de sucre réducteur urinaire (Clinitest®)
 - C. La goutte épaisse
 - D. L'échographie abdominale

FORMATION PLUS